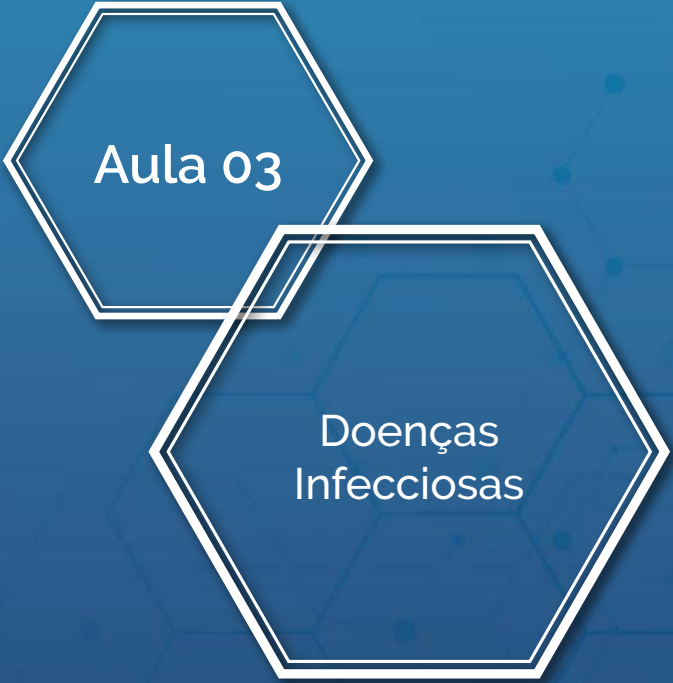


Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental

Paulo Heraldo Costa do Valle



Aula 03

Doenças
Infecciosas



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
ANALICE OLIVEIRA FRAGOSO

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

Autor

PAULO HERALDO COSTA DO VALLE

Olá. Meu nome é Paulo Heraldo Costa do Valle. Sou formado em fisioterapia, com mestrado e doutorado em fisiologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com uma experiência técnico, profissional e acadêmica na área de saúde a mais de 25 anos. Trabalhei em várias como a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), Universidade Gama Filho (UGF), Universidade Ibirapuera (UNIB), Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e Kroton Educacional. Já trabalhei como consultor AD HOC do MEC para autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação durante 10 anos e fui membro da Comissão Assessora do Curso de Fisioterapia do Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE.

- Fui membro da Comissão de Qualificação de Cursos e da Comissão de Educação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO e membro da Comissão de Sindicância do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO.
- Fui Vice Presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia e Presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia.
- Além da Telesapiens já produzi conteúdos para a Kroton Educacional, Editora Guanabara Koogan, 5G Educacional, Uninter, Delínea, Must e Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.

Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso trabalho junto com a Editora Telesapiens compondo o seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo sempre.

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias.....	12
---	-----------

Introdução	12
------------------	----

Endemia.....	13
--------------	----

Epidemia	13
----------------	----

Pandemia.....	14
---------------	----

Endemia ou epidemia.....	15
--------------------------	----

Diminuição das doenças infecciosas	16
---	-----------

Doenças infecciosas.....	16
--------------------------	----

Doença de chagas.....	17
-----------------------	----

HIV/AIDS.....	18
---------------	----

Leptospirose	19
--------------------	----

Sistema de informações de agravos de notificação	20
---	-----------

Funcionamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SIAN)	20
---	----

Operacionalização do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.....	21
---	----

Ficha individual de notificação (FIN).....	22
--	----

Ficha Individual de Investigação.....	23
---------------------------------------	----

Documentos importantes	23
Portaria GM/MS nº 47, de 03 de maio de 2016	24
Portaria GM/MS nº 1.378, de 09 de julho de 2013.....	25
Manual de normas e rotinas.....	26
Instrução Normativa – 02 de 22 de novembro de 2005	26
Sistema nacional de vigilância epidemiológica	28
Introdução.....	28
Origem do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica do Brasil.....	30
Orientação técnica	31
Funções da vigilância epidemiológica	32
Coleta de dados e informações.....	32

UNIDADE

03

DOENÇAS INFECCIOSAS

INTRODUÇÃO

Olá tudo bem com você!

Prezado aluno gostaria de convidar você neste momento para continuarmos este processo de conhecimento e aprendizagem, tenho certeza que será muito enriquecedor, repleto de desafios e estímulos para o seu o crescimento.

Você é o nosso convidado especial para continuar esta viagem através do conhecimento, durante esta trajetória você irá se deparar com trilhas muito interessantes e desafiadoras em todo este percurso.

Podemos continuar?

O tema desta terceira unidade é Transmissão de doenças e sistemas de informações, o qual está dividido nos seguintes conteúdos:

- Doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias;
- Diminuição das doenças infecciosas;
- Sistema de informações de agravos de notificação;
- Sistema nacional de vigilância epidemiológica.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3 – Doenças Infecciosas. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- Estudar em detalhes as doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias;
- Estudar em detalhes a diminuição das doenças infecciosas;
- Estudar em detalhes o sistema de informações de agravos de notificação;
- Estudar em detalhes o sistema nacional de vigilância epidemiológica.

Vamos, então, rumo ao conhecimento. Bons estudos!

Doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias

Figura 01: Doenças transmissíveis



Fonte: Freepik

Introdução

As epidemias e as endemias já existiam desde a época de Aristóteles por volta de 400 anos antes de Cristo. A história da humanidade foi marcada por grandes epidemias como:

- Peste negra;
- Surtos de cólera;
- Tuberculose também chamada de peste branca;
- Febre amarela.

Mais atualmente temos outras doenças infecciosas que provocam uma grande taxa de mortalidade como:

- Dengue;
- AIDS;
- Leishmaniose visceral;
- Influenza (BRASIL, 2009).

Os responsáveis por estas endemias e epidemias são diferentes agentes como:

- Protozoários;
- Vírus;
- Bactérias.

Existem várias formas de transmissão como:

- Contato respiratório;
- Forma direta;
- Fômites (objetos ou partículas contaminadas);
- Transmissão vetorial (mosquitos e carrapatos);
- Fezes contaminadas.

Endemia

A endemia corresponde a uma infecção que atinge uma região geográfica específica, ou seja, apenas uma determinada região, possuindo uma causa local, não espalhando- se para outras regiões (BRASIL, 2009).

VOCÊ SABIA?



A ocorrência na endemia está dentro de um número de casos já esperado para aquela região, para aquele determinado período, estando baseado quanto ao seu aparecimento nos anos anteriores não epidêmicos (LUNA, & SILVA, 2013).

Portanto a incidência uma doença endêmica é constante, existindo variações sazonais quanto ao comportamento esperado para um determinado agravo.

Epidemia

Em vários casos a endemia pode evoluir para uma epidemia, estando relacionado então com um aumento da prevalência acima da média histórica de uma determinada doença, ou seja, a relação entre o número total dos casos da doença com o número de indivíduos que

possam estar em situações risco para adquirir a doença em uma área geográfica definida, o local onde esta doença está localizada é chamado de faixa endêmica (BRASIL, 2009).

IMPORTANTE:



O causador de uma epidemia normalmente aparece de forma súbita e se propaga durante um determinado período de tempo em uma determinada área geográfica, agredindo um número elevado de indivíduos. (LUNA, & SILVA, 2013).

Pandemia

A pandemia é quando uma epidemia alcança vários países de diferentes continentes.

Os primeiros relatos de pandemia foram em 1580 na Ásia devido o vírus da gripe, sendo que em seis meses foi espalhado por toda a Europa, África e América do Norte, chegando a matar mais de 10% da população em todas as áreas afetadas (BRASIL, 2009).

Posteriormente houve outras gripes como:

- **Gripe Russa** – Surgiu no ano de 1889, atingindo a Europa e chegando ao Brasil através dos navios que chegavam a Salvador.
- **Gripe Espanhola** – Apareceu em 1918 se espalhando por todo o mundo, sendo considerada como a pior pandemia de toda a história, matando mais de 40 milhões de indivíduos em todo o mundo, o que na época representava em torno de 50% de toda a população mundial.
- **Gripe Asiática** – Surgiu na China no ano de 1957, alastrando-se posteriormente em questão de meses para a Austrália, Índia, Europa, África e Estados Unidos, chegando a atingir todos os países em apenas 10 meses (LUNA, & SILVA, 2013).

Endemia ou epidemia

Para poder avaliar se uma determinada condição é endêmica ou epidêmica é necessário determinar quais são os níveis de ocorrência habituais para uma determinada doença ou condição de saúde na população em um determinado período de tempo.

Portanto neste caso é necessário realizar um levantamento quanto ao número de casos novos, ou seja, a incidência do agravo em um período não considerado como epidêmico (BRASIL, 2009).

Esta pesquisa pode ser realizada por meio da própria equipe de Saúde da Família por meio da análise dos registros da Unidade Básica de Saúde ou por meio de uma pesquisa junto à vigilância epidemiológica do município que detém estes bancos de dados específicos.

Mesmo nos dias atuais em função de todas as mudanças e a melhoria das condições socioeconômicas de boa parte da população e a criação das vacinas e os antimicrobianos ao longo do século XX as doenças infecciosas ainda levam ao óbito por volta de 10 milhões de indivíduos em todo o mundo (LUNA, & SILVA, 2013).

Os países mais acometidos são os subdesenvolvidos que muitas vezes sofrem ao mesmo tempo com os agravos transmissíveis, agravos crônicos não transmissíveis e causas externas, sendo chamada de tripla carga de doença.

Quanto a organização dos serviços de saúde, as diversas doenças e principalmente as epidêmicas, vão afetar significativamente todo o trabalho das Unidades Básicas de Saúde (UBS), prejudicando principalmente todas as ações programadas, sendo necessário um trabalho em equipe de forma mais intensa (BRASIL, 2009).

O entendimento dos determinantes que vão levar aos agravos infecciosos é primordial para garantir um planejamento para todas as ações de enfrentamento nas situações epidêmicas e endêmicas.

Para que exista o controle quanto às epidemias e as endemias em todo o território geográfico e fundamental o trabalho das equipes de saúde da família, como também o trabalho intersetorial e as discussões

com relação a responsabilidade sanitária como um dever tanto do cidadão como da sociedade.

O trabalho da equipe de Saúde da Família, realizado principalmente pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do Agente de Controle de Endemias (ACE), possuem um papel muito importante quanto a promoção da saúde no seio familiar como também para o envolvimento dos movimentos sociais e da sociedade civil nos controles desses agravos (BRASIL, 2009).

Diminuição das doenças infecciosas

Doenças infecciosas

A partir do final do século XX, houve sem dúvida alguma uma grande redução na mortalidade devido a diminuição das doenças infecciosas e parasitárias no Brasil.

Estas reduções foram em função de várias mudanças como:

- Aumento da urbanização;
- Melhora das condições de vida;
- Maior acesso ao saneamento;
- Incorporação de tecnologias, como as vacinas, antibióticos e antivirais;
- Maior acesso aos serviços de saúde, principalmente com relação a atenção primária.

Houve uma grande queda com relação às doenças diminuindo de 45,7% do total de óbitos em 1930 nas capitais do Brasil, para 4,2 % do total de óbitos em 2011, com uma variação na região sul de 3,6% para a região norte de 5,4%.

Nas últimas três décadas houve uma grande redução na mortalidade em decorrência das diarreias, doenças preveníveis por meio de vacinação, e por infecções respiratórias em crianças.

Houve também uma redução na mortalidade em função da tuberculose de 3,6 para 2,4 por 100.000 habitantes entre 1990 e 2012.

Quanto a malária houve também uma grande redução no número de óbitos apresentando uma queda de 93,7%.

Durante este período a AIDS acabou se tornando a principal causa de mortalidade entre todas as doenças infecciosas, com mais de 12.000 óbitos por ano.

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000 houve um grande aumento dos registros da dengue, em função da grande movimentação dos sorotipos.

Agora a seguir serão abordadas algumas doenças:

- Doença de Chagas;
- HIV/AIDS;
- Leptospirose.

Doença de chagas

Até a década de 1970 o tripanossomíase americana foi considerado endêmico em 18 estados brasileiros, enquanto que a soroprevalência era de 4,2% entre os anos de 1975 a 1980.

Em 1975 foi introduzido um programa de controle, tendo como objetivo da erradicação do inseto hematófago *Triatoma infestans*.

No ano de 2006 no Brasil foi erradicado o principal vetor da enfermidade, sendo comprovado esta interrupção pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS\OMS) (SILVEIRA & DIAS, 2011).

Durante a década de 2000 no último inquérito nacional foi observado a prevalência da doença em crianças de 0,03%, sem nenhum caso identificado de transmissão vetorial.

A partir de metade da década de 1990 a transmissão transfusional foi controlada, é importante ressaltar que ainda existem por volta de 3,5 milhões de portadores da forma crônica da doença de Chagas, que foram infectados nas últimas décadas, e que representam uma importante demanda por assistência especializada (BRASIL, 2009).

HIV/AIDS

Figura 02: HIV/AIDS



Fonte: Freepik

No Brasil os primeiros casos foram registrados de forma simultânea nos Estados Unidos e Europa Ocidental.

Na primeira década da epidemia, a incidência era relativamente baixa, tendo uma concentração dos casos nas metrópoles, sendo os mais atingidos os homens que faziam sexo com os homens e os usuários de drogas injetáveis.

No ano de 2002 ocorreu um grande aumento quanto a incidência, mas que pode ser interpretado como uma melhora quanto ao sistema utilizado para o registro dos casos.

A prevalência da infecção pelo HIV para a população brasileira adulta é pequena, se for comparada com o panorama global, existe uma estimativa que por volta de 0,4% da população brasileira adulta entre 15 a 49 anos estão infectados pelo HIV, o que corresponde por volta de 530 mil pessoas, sendo que nos homens a estimativa é de 0,52% e nas mulheres de 0,31%.

Nos últimos anos devido ao trabalho realizado quanto à utilização dos testes para o HIV foi aumentada o número de pacientes que são identificados de forma precoce e houve uma redução quanto a identificação de forma tardia.

No ano de 1996 houve a introdução da terapêutica antirretroviral de alto impacto, o que acabou proporcionando um aumento na sobrevivência que era de 16 meses para 58 meses.

Nos últimos anos foi eliminado em todo o Brasil a contaminação por meio da transmissão sanguínea, enquanto com relação a transmissão através de droga injetável caiu de 17,3% para 4%, entre 2000 e 2012, no sexo masculino, e de 6,1% para 2,3%, no sexo feminino.

Leptospirose

Figura 03: Leptospirose



Fonte: Pixabay

A falta de saneamento e as precárias condições de habitação nas cidades brasileiras está intimamente relacionada com a ocorrência endêmica, chegando em alguns casos a picos epidêmicos em vários estados do Brasil.

A ocupação de forma não coordenada dos vales, margens de rios e córregos, e encostas, aliado a coleta de forma não adequada ou até inexistente dos resíduos sólidos, rede insuficiente ou não existente de drenagem de águas pluviais, acabam provocando um grande aumento na quantidade dos roedores deixando a população muito suscetível.

Atualmente são registrados por volta de 3 e 4 mil casos anuais, com uma letalidade aproximadamente de 10%.

Sistema de informações de agravos de notificação

Funcionamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SIAN)

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SIAN) funciona principalmente por meio da comunicação e análise de casos de doenças e agravos que fazem parte da lista nacional de doenças que são obrigatórias possuírem a sua notificação de acordo com a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017.

Os municípios e os estados podem ainda acrescentar outros problemas de saúde que considerem que são importantes em suas regiões, alguns exemplos quanto a esses casos são difilobotríase no município de São Paulo e a varicela no estado de Minas Gerais.



SAIBA MAIS:

Para saber mais sobre os problemas de saúde nas regiões veja a Lista Nacional de Notificações Compulsória, disponível em: <https://bit.ly/3oW8EU7>.

A utilização de forma adequada permite um diagnóstico mais dinâmico quanto a ocorrência de qualquer evento na população, garantindo subsídios que permitem esclarecimentos causais quanto os agravos de notificação compulsória.

Também vai favorecer a indicação quanto aos riscos de indivíduos que podem estar sujeitos, auxiliando então quanto à identificação da realidade epidemiológica de uma região geográfica (BRASIL, 2009).

A utilização de forma sistemática e descentralizada favorece algo que é fundamental na saúde que é a democratização da informação, possibilitando o acesso para toda a comunidade.

IMPORTANTE:

A notificação compulsória é considerada como um instrumento muito importante para auxiliar no planejamento da saúde, definindo as prioridades de intervenção, além de possibilitar que seja avaliado o impacto das intervenções.

O objetivo é possibilitar a análise da qualidade quanto a base dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação como também os cálculos dos indicadores para as equipes:

- Estaduais;
- Regionais;
- Municipais.

Esta atividade é fundamental para que os dados possam auxiliar de forma efetiva quanto às análises epidemiológicas e principalmente quanto a tomada de decisão.

Toda esta avaliação pode ser realizada por meio da assistência quanto ao:

- Encerramento das investigações;
- Completude dos campos obrigatórios das fichas de notificação e investigação;
- Indicadores epidemiológicos definidos pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde;
- Regularidade do envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação ao Ministério da Saúde;
- Tabulação de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação por meio do TabNet.

Operacionalização do Sistema de Informação de Agravos de Notificação

A operacionalização do Sistema de Informação de Agravos de Notificação pode ser realizada nas unidades de saúde, ou seja, em um

nível mais periférico, acompanhando as orientações do sistema único de saúde com relação à descentralização dos serviços.

Muitos municípios que ainda não possuem nos locais de atendimentos computadores, devem digitar essas notificações nas secretarias municipais de saúde e posteriormente os dados devem ser incluídos no sistema das regionais de Saúde.

Ficha individual de notificação (FIN)

Cada paciente que esteja com suspeita de ocorrência de um problema de saúde de notificação compulsória ou ainda de interesse nacional, estadual ou municipal deve preencher a ficha individual de notificação (FIN) nas unidades assistenciais.

Esta ficha deve ser enviada para os serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais, sendo que estas secretarias são obrigadas a repassarem todos estes arquivos a cada semana para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES).

A comunicação das Secretarias Estaduais de Saúde deve ocorrer a cada quinze dias, de acordo com o cronograma estabelecido anualmente no início do ano.

Nos casos onde um determinado período não ocorreu nenhuma suspeita de doença, as unidades de saúde também são obrigadas a preencherem um formulário, só que nesse caso será outro formulário que é chamado de formulário de notificação negativa, possuindo os mesmos prazos de entrega.

Este método foi adotado para mostrar que tanto os profissionais como o sistema de vigilância da área devem estar sempre alertas quanto a existência de eventos e ao mesmo tempo evitando a subnotificação.

Os municípios que não enviarem as suas informações para o banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação por mais de dois meses sucessivos, vão ter os seus recursos bloqueados do Piso de Assistência Básica.

ACESSE:



Acesse a Ficha Individual de Notificação, no link: <https://bit.ly/2H6MQxq>.

Ficha Individual de Notificação (dados complementares) no link: <https://bit.ly/2OVC2no>.

Ficha Individual de Notificação e a Ficha Individual de Notificação (dados complementares) no link: <https://bit.ly/2OVC2no>.

Ficha Individual de Investigação

Além da Ficha Individual de Notificação e da Notificação Negativa, existe também uma outra ficha no sistema, que é chamada Ficha Individual de Investigação (FII), sendo que corresponde a um roteiro de investigação, que permite identificar:

- Fonte de infecção;
- Mecanismos de transmissão da doença;
- Confirmação ou descarte da suspeita.

Também podem ser utilizados para a coleta de dados a planilha de surtos e os boletins que têm como objetivo o acompanhamento dos casos de hanseníase e tuberculose.



ACESSE:

Acesse a Ficha Individual de Investigação no link: <https://bit.ly/2H6MQxq>.

Documentos importantes

Existem vários documentos que são muito importantes, como: portarias, manual de normas e instrução normativa que serão abordados a seguir:

Portaria GM/MS nº 47, de 03 de maio de 2016

Esta portaria define os principais parâmetros para o monitoramento com relação a regularidade na manutenção:

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);
- Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC);
- Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Todos estes sistemas são importantes para fins de manutenção do repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde.

Nessa portaria estão presentes também todas as situações que são consideradas como irregularidades quanto à falta de informações referente ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação como também a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) quem não registrar, no período de oito semanas consecutivas as seguintes informações:

- Notificação individual de agravos de notificação compulsória;
- Notificação de surtos;
- Notificação de epizootias;
- Notificação negativa.

Existe um monitoramento quanto à regularidade da alimentação das informações quanto ao Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Sistemas de Informações de Mortalidade (SIM) pelas Secretarias Municipais de Saúde, através dos seguintes parâmetros:

I. Município com população inferior a 30.000 habitantes, estará com situação regular quando não enviar nenhuma notificação positiva ou negativa por mês de ocorrência, em dois meses consecutivos.

II. Município com população de 30.000 habitantes ou mais, será considerado situação irregular quando não for feito a transferência de pelo menos 80% de todo o volume com relação aos registros de óbitos ou de nascidos vivos por mês de ocorrência, por dois meses consecutivos.

Nessa portaria também é levada em consideração os municípios novos e os recém-criados, dando um tratamento de forma diferente para os municípios que desmembrados recentemente.

Todos estes três casos durante quatro anos a partir da data da instalação dos municípios vão receber o mesmo tratamento que os municípios que possuem menos de 30.000 habitantes.

É levado em consideração também os valores e a forma de repasse para todos os municípios, sendo considerado como irregular os casos onde o envio de informações para o Estado e/ou Municípios comprometer em 20% ou mais da meta estadual acordado para o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e Sistemas de Informações de Mortalidade, sendo que a meta era o envio de 80% do volume esperado até 60 dias posteriormente o encerramento do mês de ocorrência.

Todo este monitoramento quanto a regularidade das informações referente ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e Sistemas de Informações de Mortalidade serão todos fiscalizados pelo Ministério da Saúde mensalmente, após sessenta dias do encerramento dos dois meses que foram avaliados.

Todas as Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, que ficarem irregulares quanto ao envio das informações referentes aos sistemas Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e Sistemas de Informações de Mortalidade até a data da avaliação realizada nos meses de dezembro, abril e agosto, não receberão o repasse durante os quatro meses subsequentes do mês da avaliação.

O Fundo Nacional de Saúde vai voltar o repasse dos recursos no mês subsequente a regularização do envio das informações para os sistemas relacionados com as competências que provocaram a referida suspensão.

Portaria GM/MS nº 1.378, de 09 de julho de 2013

Essa portaria faz a regulamentação de todas as responsabilidades ao mesmo tempo em que define quais são as diretrizes tanto para a execução e o financiamento das ações de Vigilância em Saúde para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

A Vigilância em Saúde atua através de um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação dos dados com relação aos eventos referentes à saúde, buscando tanto o planejamento como também a implementação das medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Todas as ações de Vigilância em Saúde são administradas em conjunto com todos os outros serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população.

Todas as ações de Vigilância em Saúde devem envolver toda a população brasileira através de atividades e processos de trabalho relacionados com:

- Vigilância da situação de saúde da população.
- Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública.
- Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis.
- Vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências.
- Vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde.
- Vigilância da saúde do trabalhador.
- Vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde.

Manual de normas e rotinas

O manual de normas e rotinas tem a função de auxiliar quanto a padronização para a utilização de todo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, nas três esferas de governo.

Instrução Normativa – 02 de 22 de novembro de 2005

Esta instrução tem a função de regulamentar todas as atividades relacionadas com a vigilância epidemiológica referente:

- Coleta;
- Fluxo;
- Periodicidade de envio de dados.

ACESSE:



Através deste endereço <https://bit.ly/2xYxruo>, você pode observar todos os dados epidemiológicos sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, porém a última atualização de todos os dados é de 06 de março de 2017.

Ao entrar na página você terá acesso aos três itens que são:

- AIDS desde 1980;
- Doenças e agravos de notificação até 2006;
- Doenças e agravos de notificação de 2007 em diante.

Ao clicar no terceiro item você terá acesso as seguintes doenças:

- Acidentes por animais peçonhentos;
- Botulismo;
- Cólera;
- Coqueluche;
- Dengue;
- Difteria;
- Doença de Chagas;
- Doenças exantemáticas;
- Esquistossomose;
- Febre amarela;
- Febre maculosa;
- Febre tifoide;
- Hantavirose;
- Hepatite;
- Influenza pandêmica;
- Intoxicação exógena;
- Leishmaniose visceral;
- Leishmaniose tegumentar americana;
- Leptospirese;
- Malária;
- Meningite;
- Peste;

- Paralisia flácida aguda;
- Raiva;
- Sífilis em gestante;
- Sífilis congênita.
- Síndrome de rubéola congênita;
- Tétano acidental;
- Tétano neonatal;
- Violência doméstica, sexual e outras violências.

Ao clicar em cada uma das doenças você terá acesso a várias informações, por exemplo:

- Município da notificação;
- Região de saúde que fez a notificação;
- Macro região de saúde que fez a notificação;
- Faixa etária;
- Etiologia;
- Evolução;
- Entre tantas outras informações.

Sistema nacional de vigilância epidemiológica

Introdução

No início do século XX ocorreram as primeiras intervenções do governo com relação a prevenção e o controle das doenças, através de bases científicas modernas em função das grandes descobertas com relação aos ciclos epidemiológicos de algumas doenças infecciosas e parasitárias (TIETZMANN, 2014).

Todas estas medidas levaram a construção de importantes campanhas sanitárias que tiveram o objetivo de controlar as doenças que prejudicavam todas as atividades econômicas como por exemplo:

- Febre amarela;
- Peste;
- Varíola.

Todas essas campanhas utilizavam instrumentos bastante válidos para:

- Diagnóstico;
- Combate a vetores;
- Imunização;
- Tratamento em massa através dos fármacos (TIETZMANN, 2014).

O modelo operacional apresentava uma grande inspiração militar, sendo composto pelas seguintes fases:

- Preparatória;
- Ataque;
- Consolidação;
- Manutenção.

Na década de 1950 começou a ser utilizada a expressão vigilância epidemiológica para o controle das doenças transmissíveis (TIETZMANN, 2014).

O objetivo era determinar uma série de atividades imediatas à etapa de ataque da Campanha de Erradicação da Malária, vindo a constituir uma das suas fases.

Inicialmente o significado era uma avaliação de forma sistemática e ativa de casos confirmados ou suspeitos de doenças transmissíveis e seus contatos, ou seja, era a vigilância das pessoas, através de ações de isolamento ou de quarentena, sendo utilizadas de forma individual e não de forma coletiva.

O programa de erradicação da varíola na década de 1960, também contribuiu para uma fase de vigilância epidemiológica, seguindo a vacinação em massa da população.

Ao mesmo tempo o programa expandiu a utilização dos novos conceitos que fortaleciam no âmbito internacional, não estando vinculados a uma realização anterior de uma fase de ataque.

Todas estas ações estavam voltadas para a busca ativa dos casos de varíola, detecção precoce de surtos e o bloqueio imediato da transmissão da doença.

Toda esta estrutura foi considerada como fundamental para conseguir erradicar a varíola no mundo, servindo de base para a organização de sistemas nacionais de vigilância epidemiológica (TIETZMANN, 2014).

Durante a 21ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em 1968, o tema central foi a vigilância epidemiológica, onde foi abordado:

- Vários problemas de saúde pública;
- Doenças transmissíveis;
- Malformações congênitas;
- Envenenamentos na infância;
- Leucemia;
- Abortos;
- Acidentes;
- Doenças profissionais;
- Comportamentos como fatores de risco;
- Riscos ambientais;
- Utilização de aditivos.

A Campanha de Erradicação da Varíola no Brasil nos anos de 1966 a 1973 foi considerada como um importante marco quanto a institucionalização das ações de vigilância no país, servindo também para auxiliar quanto a organização das unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde.

Um dos maiores ganhos com todos estes esforços foi na década de 1980 quanto ao controle da poliomielite no Brasil, abrindo grandes possibilidades para a erradicação da doença no continente americano, finalmente alcançada em 1994.

Origem do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica do Brasil

Durante a 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.

No ano de 1977 foi elaborado através do Ministério da Saúde, o primeiro Manual de Vigilância Epidemiológica, com todas as normas técnicas para serem utilizadas na vigilância de cada doença, no âmbito de programas de controle específicos.

Após o Sistema Único de Saúde ter incorporado o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, através da (Lei nº 8.080/90), a

vigilância epidemiológica foi definida como "um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos".

Além da ampliação do conceito, todas as ações de vigilância epidemiológica começaram a ser realizadas por meio de uma grande reorganização no sistema de saúde brasileiro, sendo marcada por uma descentralização das responsabilidades, além da universalidade, integralidade e equidade na prestação de todos os serviços.

Em função das grandes mudanças quanto ao perfil epidemiológico da população, sendo verificada a diminuição quanto às taxas de mortalidade devido às doenças infecciosas e parasitárias, acompanhada de um grande aumento quanto as mortes ocorridas em função de causas externas como também as doenças crônicas degenerativas, tem levado a inclusão das doenças e agravos não transmissíveis as atividades da vigilância epidemiológica (TIETZMANN, 2014).

Orientação técnica

A vigilância epidemiológica tem como função oferecer a orientação técnica de forma permanente para todos os profissionais de saúde, que são os responsáveis quanto a decisão sobre as ações relacionadas com as doenças e agravos, atualizando todas estas informações quanto a ocorrência das doenças e agravos, como também dos fatores que as condicionam, em uma população ou área geográfica.

A vigilância epidemiológica é considerada como um importante instrumento da saúde para:

- Planejamento;
- Organização;
- Operacionalização dos serviços;
- Normatização de atividades técnicas correlatas.

As atividades da vigilância epidemiológica são constituídas através de um ciclo de funções específicas que são complementares, executadas de forma contínua, possibilitando conhecer o comportamento de cada doença ou agravo selecionado como alvo para as ações, para as medidas de intervenção possam ser realizadas.

Funções da vigilância epidemiológica

A vigilância epidemiológica apresenta várias funções como:

- Coleta de dados;
- Processamento de dados coletados;
- Análise e interpretação dos dados processados;
- Recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas;
- Promoção das ações de prevenção e controle indicadas;
- Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;
- Divulgação de informações pertinentes.

Todas as competências de cada um dos níveis do sistema de saúde sejam municipal, estadual ou federal reúnem todas as funções de vigilância epidemiológica, mas com graus variados de especificidade (TIETZMANN, 2014).

Com relação aos municípios as ações estão associadas com o conhecimento analítico da situação de saúde local, enquanto nos níveis nacional e estadual estão relacionadas com ações de caráter estratégico, coordenação em âmbito de ação e de longo alcance, como também da atuação de forma complementar ou suplementar aos demais níveis.

Através do desenvolvimento do SUS, os sistemas municipais de vigilância epidemiológica têm apresentado uma grande autonomia técnico-gerencial e ao mesmo tempo tem aumentado o enfoque não só quanto aos problemas que são considerados como prioridade nacional.

Coleta de dados e informações

Para que as funções da vigilância epidemiológica sejam atendidas é necessário que as informações estejam disponíveis para possibilitarem a produção necessária de informações para a ação.

IMPORTANTE:



A qualidade da informação está relacionada principalmente com a coleta de dados, sendo que os mesmos devem ser tratados e estruturados atuando como um instrumento muito valioso de informação, que possa auxiliar quanto ao planejamento, avaliação, manutenção e aprimoramento das ações.

Os dados devem ser coletados em todos os níveis de atuação do sistema de saúde, as informações só têm valor em função da precisão com que o dado é gerado, portanto é fundamental que todos os responsáveis pela coleta estejam preparados para que possam garantir a qualidade dos dados obtidos.

De acordo com o princípio de organização o sistema de vigilância necessita abranger o maior número possível de fontes geradoras, cuidando-se de que seja assegurada a regularidade e a oportunidade para a transmissão dos dados (TIETZMANN, 2014).

Não é necessário conhecer todos os casos, uma vez que através da utilização de fontes selecionadas e confiáveis, é possível acompanhar as tendências de uma doença ou agravo, com o auxílio de estimativas de subenumeração de casos.

As necessidades de utilização são previamente estabelecidas em função do fluxo, a periodicidade e os tipos de dados coletados, utilizando-se com base os indicadores adequados às características específicas de cada doença ou agravo sob vigilância.

Quanto à prioridade do conhecimento do dado o mesmo deve ser avaliado de acordo com a concessão para o setor responsável pela realização das medidas de prevenção e controle.

Nos casos em que for necessário o envolvimento de outro nível do sistema, este fluxo precisa ser rápido para que não exista atraso quanto a escolha medidas de prevenção e controle (TIETZMANN, 2014).

BIBLIOGRAFIA

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE – Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 7ª Edição, Brasília, 2009.

BRINQUES, GB. Higiene e Vigilância Sanitária. São Paulo, Editora Pearson, 2015.

FRANCO, LJ. Fundamentos de Epidemiologia. 2ª Edição, Editora Manole, 2011.

LUNA, EJA. & SILVA JR, JB. Doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. Vol. 2. pp. 123-176. ISBN 978-85-8110-016-6. Available from SciELO Books.

PAPINI, S. Vigilância em Saúde Ambiental: Uma nova Área da Ecologia. São Paulo, Editora Atheneu, 2012.

REIS, LGC. Vigilância Sanitária Aplicada. Curitiba, Editora Intersaberes. 2016.

TIETZMANN, D. Epidemiologia. São Paulo, Editora Pearson, 2014.